

편두통 — 위장 증상에 가려진 진짜 원인

소화불량·메스꺼움과 함께 오는 두통은 단순히 "체한 것"이 아닙니다 · ICHD-3 기준



60~90%

편두통 환자의 60~90%는 오심·구토·소화불량 등 위장 증상을 동반합니다. 두통보다 소화 증상을 먼저 호소하는 경우가 흔해, 내과에서 가장 놓치기 쉬운 질환 중 하나입니다.

편두통이 위장 질환처럼 보이는 4가지 양상

PATTERN · 01 · 전구기

두통 전 위장 증상 (Prodrome)

두통 시작 24~48시간 전 식욕 변화·메스꺼움·변비·설사·갈증. "체할 것 같다"고 표현합니다.

PATTERN · 02 · 발작 중

편두통 위마비 (Gastroparesis)

발작 중 위 배출 최대 78% 지연. 식후 더부룩함·구토·경구약 흡수 저하 — 진통제가 듣지 않는 흔한 원인.

PATTERN · 03

복부 편두통 (Abdominal migraine)

소아에 흔하지만 성인도 가능. 반복적 중앙 복통 + 오심·창백·식욕부진, 두통은 약하거나 없음. 내시경·복부검사 정상.

PATTERN · 04

순환성 구토 증후군 (CVS)

발작적 심한 오심·구토 (수 시간~수일) → 무증상기 → 다시 반복. 본인·가족력 편두통이 흔합니다.

소화불량 호소 환자에서 편두통 의심 단서 6가지

- 1 발작적·간헐적 양상 (사이에 무증상기)
- 2 위내시경·복부검사 모두 정상
- 3 증상 시 두통·머리 무거움 동반
- 4 빛·소리·냄새에 평소보다 예민
- 5 가족력 — 편두통·멀미 · 어린 시절 반복 복통
- 6 생리·수면 변화·날씨와 연관된 패턴

DIAGNOSIS · ICHD-3

진단 기준 — 5회 이상 반복

두통 특성 2가지 이상 ① 한쪽 ② 박동성 ③ 중등도~심한 강도 ④ 일상 활동에 의해 악화 · 동반증상 1가지 이상 ① 오심·구토 ② 빛·소리 과민 · 지속 4~72시간.

TREATMENT

치료 — 급성기·예방

- NSAIDs (1차)
- 트립탄 (중증)
- 제토제 병용
- 월 4회+ 예방치료
- 약물과용두통 주의
- (월 10일 이하)

RED FLAGS · 즉시 응급실 또는 정밀검사

벼락 두통 (수초 만에 극심) · 50세 이후 처음 시작된 두통 · 발열·경부강직 동반 · 한쪽 마비·언어장애·시야 결손 · 며칠~몇 주에 걸쳐 점점 심해지는 두통 · 기침·재채기에 악화되는 두통.

